

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20^ο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



*«Είναι σημαντικότερο να γνωρίζεις τι είδους ασθενής έχει την ασθένεια,
παρά τι είδους ασθένεια έχει ο ασθενής».*

William Osler, 1849-1919.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ – ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟ SHOCK

Γενικά: Η αλλεργία είναι αντίδραση υπερευαισθησίας, που επάγεται μέσω ανοσολογικών μηχανισμών. Η αλλεργία μπορεί να διαμεσολαβείται από αντισώματα ή από κύτταρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το αντίσωμα που χαρακτηριστικά ευθύνεται για μια αλλεργική αντίδραση ανήκει στον IgE ισότυπο και κατά συνέπεια τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται ως πάσχοντα από μία IgE-μεσολαβούμενη αλλεργία. Οι IgE-μεσολαβούμενες αλλεργικές αντιδράσεις, δεν συμβαίνουν αποκλειστικά μόνο σε ατοπικά άτομα.

Η οξεία αντίδραση υπερευαισθησίας προκαλεί, αντικειμενικά, διάφορα σταθερώς αναπαραγόμενα συμπτώματα ή κλινικά σημεία, τα οποία εμφανίζονται μετά από έκθεση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, καλώς ανεκτό από τα φυσιολογικά (μη αλλεργικά) άτομα.

Ιστορικό: Εξετάζουμε αν ο ασθενής είναι γενικά αλλεργικός ή αν πάσχει από συστηματικό νόσημα (π.χ. λέμφωμα, ΣΕΛ, παρασίτωση) που μπορεί να προκαλέσει κνίδωση. Εξετάζουμε τι πυροδότησε την οξεία αντίδραση υπερευαισθησίας (τροφή, φάρμακο, γύρη, χημική ουσία, επαφή με φυτό, νυγμός εντόμου ή δήγμα φιδιού ή μέδουσας, latex, εμβόλιο, άσκηση, κ.λπ.).

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής μας, μπορεί να παρουσιάζει εξάνθημα, κνίδωση, εφίδρωση, ανησυχία, δύσπνοια, βρογχόσπασμο, συριγμό. Ακόμα κι αν ο ασθενής εμφανισθεί στο ΤΕΠ μόνο με κνίδωση ή ήπιο ερύθημα, πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορεί - ανά πάσα στιγμή - να αναπτύξει βαριά αναφυλακτική αντίδραση και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται επείγοντως, όπως φυσικά κάθε ασθενής που εμφανίζεται με πλήρη εκδήλωση αναφυλακτικού shock.

Σε γενικευμένη αλλεργική αντίδραση και σε **αναφυλακτικό shock**, μπορεί να εμφανιστούν:

- ▶ Ταχυκαρδία, αρρυθμίες, υπόταση, καρδιακή ισχαιμία (σύνδρομο Κούνη), ανακοπή.
- ▶ Δύσπνοια, ταχύπνοια, βρογχόσπασμος, συριγμός, κυάνωση, αναπνευστικό arrest.
- ▶ Ρινική συμφόρηση, πταρμός, βήχας, οίδημα σταφυλής, βράγχος φωνής.
- ▶ Εξάνθημα, ερύθημα, κνησμός, κνίδωση, αγγειοοίδημα, flushing.
- ▶ Ζάλη, αδυναμία, σπασμοί, συγκοπτικό επεισόδιο.
- ▶ Επιπεφυκίτιδα, δακρύρροια, θάμβος όρασης.
- ▶ Κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετοι, διάρροιες.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις, αναπνοές, SpO_2 , θερμοκρασία) και τον καθησυχάζουμε. Δεν πρέπει να υποτιμούμε ποτέ μία αλλεργική αντίδραση στα αρχικά της στάδια, γι' αυτό δρούμε γρήγορα και μεθοδικά: ενώ ενημερώνουμε τόσο τον ασθενή όσο και τους οικείους του για την πιθανότητα υποτροπής των συμπτωμάτων μετά την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση και εφιστούμε την προσοχή τους το πρώτο 24ωρο.
2. Στις ελαφρές περιπτώσεις αναφυλαξίας, όπου εμφανίζονται ήπια και τοπικά συμπτώματα (ερυθρότητα, εξάνθημα, κνησμός) χορηγούμε αντισταμινικά, ήτοι 1 amp. **Διμεθινδένη** (Fenistil) σε 100-250 ml N/S (iv), εντός 15-20 λεπτών ή εφόσον δεν επιτευχθεί φλεβική πρόσβαση **Χλωρφαιναμίνη** (Istamex, tabl. 4 mg) ή **Δεσλοραταδίνη** (Aerius, tabl. 5 mg) ή **Λεβοσετιριζίνη** (Xozal, tabl. 5 mg) ή τέλος **Βιλαστίνη** (Bilaz/Bilargen, tabl. 20 mg).
3. Χορηγούμε, αναλόγως ηλικίας ή σωματικού βάρους, είτε **Μεθυλπρεδνιζολόνη**, δηλαδή 1 amp. *Lyo-Drol* (40 mg, 125 mg ή 500 mg) ή το προτιμότερο **Υδροκορτιζόνη**, δηλαδή 1 amp. *Lyo-Cortin* (100 mg, 250 mg ή 500 mg), ενδομυϊκά ή bolus βραδέως ενδοφλεβίως. **Σε περίπτωση βρογχόσπασμου, τα κορτικοειδή κρίνονται απαραίτητα**, καθώς και για το γεγονός ότι στο 25-30% των περιπτώσεων, η αλλεργική αντίδραση είναι διφασική, με τη 2^η φάση να εμφανίζεται μετά από 1-8 ώρες και ενίοτε με μεγαλύτερη βαρύτητα!
4. Επίσης, 1-2 amp. Σιμετιδίνη 200 mg (*Tagamet*) διαλυμένη σε 100 ml N/S, για την κάλυψη των H_2 ισταμινικών υποδοχέων: διότι έχει βρεθεί ότι με τους H_2 αναστολείς επιταχύνεται, ειδικότερα, η υποχώρηση των δερματικών εκδηλώσεων της αναφυλαξίας. [Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι οι PPIs (*Losec*, *Nexium*, κ.λπ.) δεν έχουν λόγο χορήγησης στην αναφυλαξία].

5. Χορηγούμε O₂ με μάσκα νεφελοποίησης στα 4-6 lt/min, μαζί με βρογχοδιασταλτικά και εισπνεόμενα κορτικοειδή, ιδίως επί βρογχόσπασμου (SABA/ICS: *Aerolin/Pulmicort*).
6. Αναλόγως της βαρύτητας του βρογχόσπασμου κι εφόσον δεν υπάρχει συννοσηρότητα από το καρδιαγγειακό σύστημα ή αρρυθμία, χορηγούμε Αμινοφυλλίνη ή Θεοφυλλίνη, δηλαδή: 1 amp. Aminophylline 250 mg ή Uniphillin 240 mg, σε 500 ml N/S, εντός 30-45 λεπτών.

Στην απευκταία περίπτωση – τόσο για τον ασθενή όσο και για τον ιατρό – που η αλλεργική αντίδραση εξελίσσεται σε **αναφυλακτικό shock** (οίδημα αεραγωγών - διόγκωση σταφυλής, βράγχος φωνής, συριγμός, δυσκολία στην αναπνοή, κυάνωση, υπόταση, ταχυκαρδία, μειωμένη τριχοειδική επαναπλήρωση), τότε δρούμε ψύχραιμα, γρήγορα και μεθοδικά, όπως παρακάτω:

7. Τοποθετούμε τον ασθενή σε θέση Trendelenburg για βελτίωση της φλεβικής επιστροφής.
8. Πρωτίστως, μεριμνούμε για την εξασφάλιση του αεραγωγού και για επαρκή αερισμό.
9. Χορηγούμε O₂ σε υψηλές ροές 6-10 lt/min, με προσωπίδα ή μάσκα Venturi (31-40%).
10. Χορηγούνται 0,3-0,5 ml του διαλύματος **Αδρεναλίνης** 1:1000* [im], (σε ενήλικες και σε παιδιά > 12 ετών). Επανάληψη της δόσης ανά 10-15 min, αν η εικόνα του shock επιμένει. Η ενδομυϊκή χορήγηση (προτιμάται ο μηρός παρά ο δελτοειδής μυς) υπερτερεί σαφώς της υποδόριας, εξαιτίας της περιφερικής αγγειοσύσπασης και της πενιχρής αιμάτωσης του υποδόριου ιστού στην κατάσταση shock. Η βραδεία στάγδην (iv) χορήγηση αδρεναλίνης δεν συνιστάται, τουλάχιστον κατά την αρχική αντιμετώπιση του αναφυλακτικού shock.

Προσοχή: Ασθενείς που λαμβάνουν β-αναστολείς (πιθανώς και α-MEA) για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, μπορεί να μην ανταποκρίνονται επαρκώς στη χορήγηση αδρεναλίνης, οπότε σε αυτούς πρέπει να χορηγηθεί **Γλυκαγόνη** σε δόση 1-2 mg (iv), κάθε 5-10 λεπτά.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα σκευάσματα Γλυκαγόνης τα οποία κυκλοφορούσαν μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα (*Glucagen*) χορηγούνται μόνον ενδομυϊκώς (im) ή υποδορίως (sc).

11. Αναπληρώνουμε την ένδεια όγκου υγρών, με την χορήγηση 1000 ml NaCl 0,9% (iv). Σε εμμένουσα ή βαριά υπόταση ($MAP < 65 \text{ mmHg}$), μετά από ταχεία φόρτιση 1-2 lt υγρών, τότε χορηγείται αδρεναλίνη, ελεγχόμενα βραδέως (iv). Ήτοι, 1 αμπούλα 1 ml του έτοιμου διαλύματος αδρεναλίνης 1:1000 διαλύεται σε 100-500 ml N/S και χορηγείται με συσκευή μικροσταγόνων, εντός 20-30 λεπτών, υπό συνεχές monitoring καρδιακού ρυθμού και ΑΠ.
12. Επαναλαμβάνουμε την ενδοφλέβια χορήγηση αντιϊσταμινικών, σε άλλη μία ή δύο δόσεις [Διμεθινδένη (*Fenistil 4 mg*)] ή τη δόση από στόματος: Χλωρφαιναμίνη (*Istamex 4 mg*) ή Δεσλοραταδίνη (*Aerius 5 mg*) ή Βιλαστίνη (*Bilaz 20 mg*). Προσοχή στην υπόταση και τη ναυτία από τη Διμεθινδένη, που μπορεί να εκληφθούν ως επίταση του αλλεργικού shock.
13. Εφόσον η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται, διακομίζουμε άμεσα στο νοσοκομείο, συνοδεύει ιατρού, υπό συνεχές monitoring (ΑΠ, ΗΚΓ-ρυθμού, RR, SpO₂), εφαρμόζοντας την ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή και εντός του ασθενοφόρου, κατά τη διακομιδή.
14. Δίνουμε οδηγίες στον ασθενή για την ειδική διατροφή που πρέπει να ακολουθήσει, καθώς και τα φάρμακα που θα λάβει για τις επόμενες 5-7 ημέρες από το συμβάν της αλλεργίας.

Όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν σοβαρή αντίδραση δικαιούνται τη χορήγηση βεβαίωσης για προμήθεια του έτοιμου προγεμισμένου προς χρήση στυλό Αδρεναλίνης (**Anapen**). Η δόση στη συσκευή ενηλίκων είναι 0,3 mg Αδρεναλίνης, ενώ για παιδιά είναι 0,15 mg.

Μετά το πέρας της σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης παραπέμπουμε τον ασθενή σε Αλλεργιολογικό Ιατρείο για ειδικό έλεγχο, εξετάσεις και πιθανή έναρξη ανοσοθεραπείας.

Η επιλογή ασθενών για Ανοσοθεραπεία στηρίζεται κυρίως στα εξής δεδομένα:

- Προϊούσα αύξηση της συχνότητας των επεισοδίων ή της σοβαρότητας της νόσου.
- Αποτυχία των περιβαλλοντικών μέτρων να μειώσουν τα επεισόδια.
- Σοβαρές αλλεργίες από τροφές, γύρεις, ακάρεα και μύκητες.
- Συνύπαρξη των κνιδωτικών επεισοδίων με αλλεργική ρινίτιδα.
- Κορτικοεξαρτώμενο άσθμα με συχνές και σοβαρές υποτροπές ή νοσηλείες.

* Το έτοιμο διάλυμα Αδρεναλίνης του εμπορίου, που περιέχεται στην αμπούλα του 1 mg/ml, βρίσκεται ήδη σε αραίωση 1:1000 και είναι έτοιμο προς χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.